BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM RPR
(Rapid plasam reagin)

Mã hiệu: **VS.MD.31.01** - Bản số: ..01..**VS**

Ngày hiệu lực : ..15../..04./2025

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
Trưởng khoa					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này hướng dẫn các bước thực hiện xét nghiệm phát hiện kháng thể không đặc hiệu RPR (Rapid plasma reagin) trong máu.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng tại nhóm miễn dịch khoa Vi sinh - Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Các nhân viên thuộc khoa Vi sinh được phân công có trách nhiệm thực hiện quy trình này và lưu hồ sơ theo quy định của quy trình này.
- Nhân viên có trình độ đại học hoặc sau đại học có trách nhiệm nhận định và phê duyệt kết quả.
- Trưởng khoa, Nhân viên QLCL chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình này.

4. NGUYÊN LÝ

- Kháng nguyên lipid (Cardiolipin) lấy từ phủ tạng người bị bệnh giang mai hoặc tim bê, tim bò.
- Kháng nguyên Cardiolipin được gắn than hoạt tính, khi cho tiếp xúc với huyết tương hoặc huyết thanh của người bị bệnh giang mai sẽ cho phản ứng dương tính, biểu hiện bằng hiện tượng lên bông.

5. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG, CHỮ VIẾT TẮT

a) Thuật ngữ sử dụng: không áp dụng

b) Chữ viết tắt:

- QC (Quality control): Nội kiểm tra chất lượng
- QLCL: Quản lý chất lượng
- RPR: Rapid plasma reagin

6. TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ

a) Trang thiết bị

- Máy ly tâm thường
- Tủ lạnh 2-8°C, tủ âm sâu (-20°C)

b) Dụng cụ

- Bìa phản ứng
- Giấy thấm
- Bút viết kính
- Găng tay, khẩu trang
- Micropipet thể tích 10µl – 100µl, đầu côn 100µl

c) Hóa chất

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Kit RPR Carbon

d) Mẫu bệnh phẩm

- Huyết thanh hoặc huyết tương của người bệnh

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Thực hiện kiểm tra chứng dương, chứng âm đầu ngày trước khi làm cho bệnh nhân.
- Bìa phản ứng phải sạch.

8. AN TOÀN

- Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý mẫu và thực hiện theo quy định trong sổ tay an toàn STAT.XN.
- Xem tất cả các mẫu thử nghiệm như là nguồn lây nhiễm.
- Xử lý các dụng cụ theo đúng quy trình khử khuẩn và tiệt khuẩn.
- Nếu xảy ra đổ tràn với mẫu nội kiểm xử trí theo quy trình xử lý sự cố đổ tràn trong sổ tay an toàn STAT.XN.
- Rác thải, găng tay, nước thải đưa vào hệ thống rác thải y tế, xử lý theo quy trình của bệnh viện.
- Chỉ sử dụng trong chẩn đoán invitro. Không tái sử dụng dụng cụ xét nghiệm.
- Không trộn lẫn hoặc làm lẫn lộn các mẫu xét nghiệm khác nhau.

9. NỘI DUNG THỰC HIỆN

9.1. RPR định tính

- Nhỏ 40µl huyết thanh (hoặc huyết tương) vào 1 vòng tròn trên bìa phản ứng.
- Huyết thanh chứng dương và chứng âm đồng thời được thực hiện.
- Dùng que dẹt dàn đều huyết thanh trong giới hạn vòng tròn.
- Lắc nhẹ giọt kháng nguyên, rồi nhỏ 20µl (1 giọt) kháng nguyên vào vòng tròn đã có huyết thanh (không khuấy trộn).
- Lắc tốc độ 100 vòng/phút trong 8 phút.
- Đọc kết quả sau 8 phút.

9.2. RPR định lượng

- Huyết thanh pha loãng dần, tới độ pha loãng lớn nhất cho kết quả dương tính. Pha loãng huyết thanh bán toàn phần với tỷ lệ: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,... 1/1024.
- Nhỏ 40µl NaCl 0.9% vào mỗi vòng tròn bìa phản ứng, nhỏ 40µl huyết thanh vào vòng tròn 1, trộn đều, chuyển 40µl (huyết thanh đã pha loãng) sang vòng tròn 2, trộn đều rồi chuyển tiếp tới các vòng tròn sau.
- Dùng que dẹt, dàn đều huyết thanh trong giới hạn vòng tròn.
- Lắc nhẹ giọt kháng nguyên, rồi nhỏ 20µl (1 giọt) kháng nguyên vào vòng tròn đã có huyết thanh (không khuấy trộn).

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Lắc tốc độ 100 vòng/phút trong 8 phút.
- Đọc kết quả sau 8 phút.

10. DIỄN GIẢI VÀ BÁO CÁO

- Âm tính: Đám than hoạt tính tập trung ở giữa vòng tròn, màu xám đồng nhất.
- Dương tính yếu: Có ít các hạt kết cụm màu đen bao quanh rìa vòng tròn bìa phản ứng.
- Dương tính: Có các hạt kết cụm màu đen (hiện tượng lên bông) trên khắp mặt hoặc trung tâm vòng tròn của bìa phản ứng.
- Nhận định kết quả RPR định lượng:

Hiệu giá	Vòng tròn 1 (1:1)	Vòng tròn 2 (1:2)	Vòng tròn 3 (1:4)	Vòng tròn 4 (1:8)	Vòng tròn 5 (1:16)
1:2	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)
1:4	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)
1:8	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)
1:16	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)

- Biện luận kết quả:

RPR âm tính		RPR dương tính	
TPHA âm	TPHA dương	TPHA âm	TPHA dương
- Không bị nhiễm - Đã điều trị khỏi - Giang mai mới nhiễm (< 3 tuần) - Giang mai ở người suy giảm miễn dịch (HIV)	- Giang mai kín muộn - Giang mai đã điều trị - Một số ít trường hợp TPHA dương tính giả (1-2%)	- Phản ứng RPR dương tính giả - Giang mai thời kỳ I	- Giang mai chưa điều trị - Giang mai được điều trị muộn

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Phản ứng có thể cho kết quả dương tính giả trong một số bệnh: Lupus ban đỏ, sốt rét, bệnh phong, bệnh tăng tế bào đơn nhân nhiễm trùng, phụ nữ có thai,…
- Luôn phải dùng xét nghiệm đặc hiệu để khẳng định. Nếu kết quả không rõ ràng, làm lại bằng xét nghiệm đặc hiệu khác.
- Làm xét nghiệm không đặc hiệu RPR định lượng trước khi tiến hành điều trị để là cơ sở theo dõi điều trị.
- Nếu lâm sàng nghi ngờ mà xét nghiệm âm tính => làm lại xét nghiệm sau 2-4 tuần.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

12. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

- Không áp dụng

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Hướng dẫn sử dụng micropipet	VS.HD.12

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học, ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.